

UROSEPSE — ATB PRECOCE + DESOBSTRUIR

ESPECTRO DA INFECÇÃO URINÁRIA ALTA

Quadro	Características	Manejo
Pielonefrite não complicada	Mulher hígida, não gestante, trato urinário normal	Frequentemente ambulatorial (VO)
Pielonefrite complicada	Homem, gestante, DM, obstrução, cateter, anomalia, imunossupressão	Internação e ATB IV em muitos casos
Urosepses	Pielonefrite + disfunção orgânica (sepse)	ATB IV precoce + ressuscitação + buscar obstrução
Pielonefrite obstrutiva	Cálculo/obstrução + infecção (pionefrose)	EMERGÊNCIA: desobstrução urgente (nefrostomia/cateter)
Abscesso renal/perinéfrico	Febre persistente apesar de ATB	Imagem (TC) + drenagem

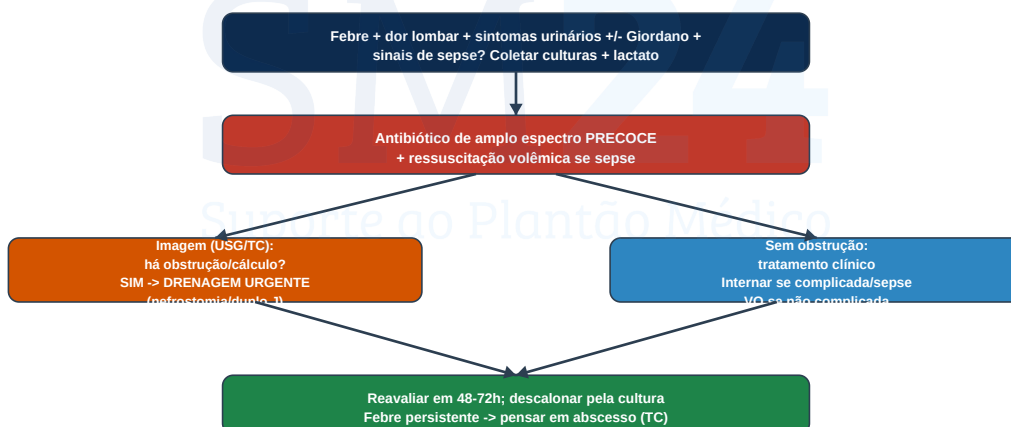
O QUE NÃO PODE FALHAR NA UROSEPSE

ANTIBIÓTICO PRECOCE + DESCARTAR OBSTRUÇÃO

- Sepse com foco urinário: antibiótico de amplo espectro na 1ª hora + ressuscitação volêmica guiada por metas + lactato
- Hemoculturas e urocultura ANTES do antibiótico (mas sem atrasar o ATB)
- Cálculo/obstrução + infecção = pionefrose: DRENAGEM URGENTE (nefrostomia percutânea ou cateter duplo J) — o antibiótico isolado não resolve
- Não atrasar a desobstrução em paciente séptico com obstrução (risco de morte e perda do rim)
- Avaliar gravidade (qSOFA/SOFA) e o nível de cuidado (UTI se choque/lactato alto)
- Reavaliar e descalonar o antibiótico conforme a cultura e o antibiograma

ABORDAGEM DA PIELONEFRITE/UROSEPSE

FOCO URINÁRIO — TRATAR + DESOBSTRUIR



ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA

Rx AJUSTAR PELO RISCO E PELA CULTURA

Pielonefrite não complicada (ambulatorial): ciprofloxacino VO OU ceftriaxona dose inicial e depois VO — conforme perfil de resistência local

Pielonefrite complicada / internação: ceftriaxona 1-2 g IV/dia OU ciprofloxacino IV

Uroseps / grave: piperacilina-tazobactam OU cefepima; carbapenêmico se risco de ESBL

Risco de Pseudomonas (cateter, internação, manipulação): cefepima ou piperacilina-tazobactam

Suspeita de enterococo (idoso, cateter): considerar ampicilina associada

Gestante: ceftriaxona IV (evitar quinolona); internar pela maior taxa de complicação

Duração: 7 dias (quinolona) a 10-14 dias conforme gravidade; descalonar pela cultura

POPULAÇÕES E COMPLICAÇÕES

Quando Internar

- Sepses/instabilidade hemodinâmica
- Vômitos/incapacidade de VO, desidratação
- Gestante com pielonefrite
- Obstrução do trato urinário
- Imunossupressão, DM descompensado, comorbidade grave
- Falha do tratamento ambulatorial em 48-72h

Sinais de Complicação

- Febre persistente > 72h apesar de antibiótico adequado -> abscesso (TC)
- Pionefrose: rim obstruído e infectado (drenagem urgente)
- Pielonefrite enfisematosa (DM): gás no parênquima — grave
- Lesão renal aguda, choque séptico
- Bacteremia persistente (rever foco/drenagem)
- Recidiva precoce: investigar fator estrutural

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Coletar hemoculturas e urocultura antes do antibiótico (sem atrasar o ATB)
- ☐ Antibiótico de amplo espectro precoce; ressuscitação volêmica e lactato na sepsse
- ☐ Imagem (USG/TC) para descartar obstrução em sépticos e em casos complicados
- ☐ Obstrução + infecção = drenagem urgente (nefrostomia/duplo J) — o ATB isolado não basta
- ☐ Internar gestante, séptico, obstruído, imunossuprimido ou com falha ambulatorial
- ☐ Reavaliar em 48-72h, descalonar pela cultura e investigar abscesso se febre persistente

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com pielonefrite, cálculo obstruindo o ureter e quadro de sepse. Além do antibiótico, qual a conduta essencial?

- A) Aguardar a resposta ao antibiótico por 72h
- B) Drenagem urgente da via urinária obstruída (nefrostomia percutânea ou cateter duplo J)
- C) Apenas hidratação
- D) Litotripsia eletiva ambulatorial
- E) Suspender o antibiótico e observar

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Gestante com pielonefrite aguda. Qual a conduta mais adequada?

- A) Tratamento ambulatorial com ciprofloxacino VO
- B) Internação e antibiótico IV (ex.: ceftriaxona), evitando quinolona
- C) Apenas sintomáticos
- D) Nitrofurantoína por 3 dias
- E) Aguardar a urocultura antes de qualquer tratamento

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Na urosepse, qual a janela ideal para o início do antibiótico de amplo espectro?

- A) Após o resultado da urocultura
- B) Na primeira hora, após coletar as culturas
- C) Somente se a febre persistir por 24h
- D) Apenas após a tomografia
- E) Não é necessário antibiótico precoce

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente com pielonefrite mantém febre alta após 72h de antibiótico adequado. Qual a principal hipótese e o exame?

- A) Resistência viral — sorologia
- B) Abscesso renal/perinéfrico — tomografia de abdome
- C) Alergia ao antibiótico — suspender tudo
- D) Cistite simples — urocultura
- E) Pneumonia — radiografia de tórax

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual paciente caracteriza pielonefrite COMPLICADA?

- A) Mulher jovem, hígida, com trato urinário normal
- B) Homem, gestante, diabético, com obstrução ou cateter urinário
- C) Adolescente sem comorbidades
- D) Paciente com cistite não complicada
- E) Mulher com infecção urinária baixa de repetição sem febre

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Pielonefrite obstrutiva com sepse (pionefrose) exige DRENAGEM URGENTE da via urinária (nefrostomia percutânea ou cateter duplo J) além do antibiótico — o ATB isolado não resolve a coleção infectada sob pressão, e o atraso aumenta a mortalidade e o risco de perda do rim.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A gestante com pielonefrite deve ser internada (maior taxa de complicações, incluindo parto prematuro e sepse) e tratada com antibiótico IV, como ceftriaxona, evitando-se as quinolonas na gestação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na uroseps, o antibiótico de amplo espectro deve ser iniciado na primeira hora, após a coleta de hemoculturas e urocultura, junto com a ressuscitação volêmica — o atraso aumenta a mortalidade.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Febre persistente após 72h de antibiótico adequado na pielonefrite sugere abscesso renal ou perinéfrico (ou obstrução não resolvida). A tomografia de abdome é o exame para identificar a coleção, que pode requerer drenagem.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Pielonefrite complicada é a que ocorre em homem, gestante, diabético, imunossuprimido ou em paciente com alteração estrutural/funcional do trato urinário (obstrução, cateter, anomalia). Esses casos frequentemente exigem internação e antibiótico IV.

SM24
Suporte ao Plantão Médico